Classification TNM 2017 (AJCC 8e édition), stratification du risque et prise en charge du CDT

À RETENIR

- Âge seuil : **45 ans** (2010) → **55 ans** (2017).
- L'EET microscopique n'est plus prise en compte : **T3a** = **> 4 cm**, **T3b** = EET macroscopique ; secteur VII → **N1a** ; stade IVc réservé à l'anaplasique.
- TNM 2017 : plus rassurant, reflète mieux la réalité, désescalade thérapeutique.
- ATA : 3 stades (gg > 3 cm → haut risque) ; ETA : 4 stades.
- Risque de récidive : FR **5–10 %**, RI **15–20 %**, HR **> 30 %**.
- FR < 2 cm : Tg à **4–6 semaines** post-op ; surveillance si Tg **< 5 ng** (lobo-isthmectomie) ou **< 2 ng** (TT).
- Activités : FR > 2 cm **30 mCi** sous TSHrh (optionnel) ; RI faible **30–100 mCi** (optionnel) ; RI haut **100 mCi** (recommandé) ; HR **100–200 mCi** en sevrage.

I. Points de classification

- pT1a ou pT1b avec EETm (extension extrathyroïdienne microscopique) → **faible risque**.
- pT2 avec EETm → **risque intermédiaire**.
- Atteinte sous-cutanée = **pT4a** (corrigé de pT3 dans les notes).
- Ganglion rétropharyngé → pT N1b.

II. Différences TNM 2010 / TNM 2017 (8e édition)

	TNM 2010	TNM 2017
Âge	< 45 ans et ≥ 45 ans	< **55 ans** et ≥ **55 ans**
Stade AJCC	IVc pour M1	IVc réservé à l'anaplasique
T3	Si EETm, quelle que soit la taille	EETm n'est plus prise en compte : T3a → **> 4 cm** ; T3b → EET macroscopique
Secteur VII	—	VII → N1a

Conséquences du TNM 2017 : plus **rassurant** ; reflète le mieux la réalité ; **désescalade thérapeutique**.

III. ATA vs ETA

ATA	ETA
3 stades	4 stades
Ganglion > 3 cm → haut risque	1 ganglion → haut risque
Ne suit pas l'OMS	
Prend le BPT (balayage post-thérapeutique) comme critère	

Groupes de risque (récidive)

Groupe	Risque	Critères
Faible risque (FR)	**5 à 10 %**	Tous les critères ; BRAF < 1 cm
Risque intermédiaire (RI)	**15 à 20 %**	1 critère ; BRAF < 4 cm

Groupe	Risque	Critères
Haut risque (HR)	**> 30 %**	1 critère ; BRAF + RET **[à vérifier]** *à vérifier : l'ATA retient l'association BRAF + TERT*

IV. Prise en charge du CDT selon le risque

1. Faible risque (FR)

- **< 2 cm** : Tg à **4 à 6 semaines** post-op
  - Tg **< 5 ng** si lobo-isthmectomie, **< 2 ng** si TT → **surveillance** ;
  - si supérieure ou facteur de mauvais pronostic → totalisation chirurgicale ; la cure est discutable : **30 mCi** sous TSHrh.
- **> 2 cm** : ^{131}I = **30 mCi** sous TSHrh → optionnel.

2. Risque intermédiaire (RI)

(> 1 critère ; atteinte ganglionnaire)

- RI faible (FRI) : optionnel, **30–100 mCi**.
- RI haut (HRI) : recommandé, **100 mCi**.

3. Haut risque (HR)

- **100–200 mCi** en sevrage.
- TT + curage ; curage prophylactique pour T3–T4 ; curage central et latéral si N⊕.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quel est le seuil d'âge du TNM 2017 ?	55 ans (45 ans en 2010).
2. Définissez T3a et T3b (TNM 2017).	T3a : > 4 cm ; T3b : extension extrathyroïdienne macroscopique.
3. Où est classé le secteur VII en 2017 ?	N1a.
4. Une atteinte sous-cutanée correspond à quel T ?	pT4a.
5. Différences ATA / ETA ?	ATA : 3 stades, gg > 3 cm = haut risque ; ETA : 4 stades, 1 gg = haut risque.
6. Seuils de Tg post-op permettant la surveillance d'un FR < 2 cm ?	< 5 ng après lobo-isthmectomie, < 2 ng après TT.
7. Activités d'^{131}I selon le risque ?	FR > 2 cm : 30 mCi (optionnel) ; RI faible 30–100 mCi ; RI haut 100 mCi ; HR 100–200 mCi en sevrage.